抗凝血藥與抗血小板藥

俗稱「血路藥」。它在防中風、防心肌梗塞，但也會比較容易流血

最重要的一句：要開刀、拔牙或做檢查前，一定要先讓醫師知道你在吃

掃描看電子版

我為什麼要吃？兩類藥差在哪？

血塊的成因不同，用的藥就不同，不能互相取代

抗凝血藥　對付「血流太慢」結的血塊

心房顫動 —— 預防中風（最常見）

深部靜脈血栓、肺栓塞

裝過機械瓣膜

血在心房或靜脈裡流太慢而凝結

抗血小板藥　對付「斑塊破掉」結的血塊

心肌梗塞、放過支架

缺血性腦中風、小中風

周邊動脈疾病

動脈硬化斑塊破裂，血小板立刻聚集

台灣常見的藥有哪些？

認自己的藥名，比記藥袋顏色可靠

抗凝血藥		抗血小板藥	
Warfarin	可邁丁	Aspirin	阿斯匹靈（如伯基）
Dabigatran	普栓達 Pradaxa	Clopidogrel	保栓通 Plavix
Rivaroxaban	拜瑞妥 Xarelto	Ticagrelor	百無凝 Brilinta
Apixaban	艾必克凝 Eliquis	Prasugrel	Effient
Edoxaban	里先安 Lixiana	Cilostazol	Pletaal

只有 Warfarin（可邁丁）要定期抽血驗 INR；其餘四種新型抗凝血藥不用常規驗，但要固定時間吃、不能漏。

平常要注意什麼？

目標是「不漏吃，也不要多流血」

- 定時吃不要漏
- 止痛藥先問
- 中草藥先問
- 軟毛牙刷
- 小心跌倒
- 帶用藥卡

吃 Warfarin（可邁丁）的人：深綠色蔬菜、納豆含維生素 K，重點是「吃得穩定」，不是完全不吃。

要開刀、拔牙或做檢查怎麼辦？

不要自己停，也不要自己繼續吃

這些通常不用停

洗牙、補牙、單純拔一兩顆牙

白內障手術、皮膚小手術、不切片的內視鏡

要停的話，常見天數

可參照詳細版說明

新型抗凝血藥 1~2 天（腎功能差要更久）

可邁丁約 5 天　保栓通約 5 天　百無凝 3~5 天

一年內放過心臟支架的人，絕對不可以自己停抗血小板藥

可能造成支架內血栓，死亡率比第一次心肌梗塞還高。停與不停由心臟科醫師決定。

手術後什麼時候吃回去？

由開刀的醫師確認止血穩定後決定

小處置、出血風險低	大手術、出血風險高	不要自己拖延
約 24 小時後	約 48~72 小時後	停太久反而會中風或梗塞

出現這些情況，立刻就醫

解黑便、血便　·　吐血或咖啡色嘔吐物　·　血尿、咳血　·　牙齦或鼻子流血止不住

突然劇烈頭痛、單側無力、口齒不清、意識改變　·　不明瘀青一直擴大、頭暈臉色蒼白

頭部撞到一定要就醫——即使當下看起來沒事，顱內出血可能幾小時到幾天後才出現。

資料來源（查核至 2026 年 10 月）

2024 ESC 心房顫動指引 · EHRA 新型口服抗凝血劑臨床實用指引 · 2025 ACC/AHA 急性冠心症指引 · 中華民國心臟學會相關指引 · 美國牙醫學會抗凝血 / 抗血小板